

Información Paciente

Nombre : Roberto Hernan Baeza Llancafil
Edad : 61a 10m 29d
Dirección : Calle Del Rio 0115

Rut : 9.602.159-3
Fecha Nacto: 29/11/1962
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A691256
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7257 2665

N° Epicrisis
418692

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 15/10/2024 15:11

Días Estadía: 13

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 28/10/2024 20:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

Médicos - Quirúrgicos - Alergicos: Niega

Antecedente de caída 10/10/24, se resbala y golpea en coxis y rodilla izq. acude a urgencias donde realizan scanner se evidencia fx no complicada de coxis y aumento de volumen de rodilla derecha. con muestra de punción de liquido articular no inflamatorio. envían al hogar con celecoxib y paracetamol

hábitos: alcohol 1 vez cada 2 sem, cerveza llegando al estado de ebriedad.

Maestro de obra metro.

MC: compromiso de conciencia.

Diagnostico:

Shock septico de foco meningeo con disfuncion multiorganica SOFA

Inestabilidad Hemodinamica

Compromiso de conciencia

AKI 2

disfuncion hepatica.

Acidosis metabolico moderada.

Insuficiencia respiratoria secundaria a compromiso de conciencia

Neumonia aspirativa.

27/10/2024 18:03:59

M.Becerra

Fecha Epicrisis : 28/10/2024 20:18

Fecha Última Actualización: 28-10-2024 20:18:37

Página 2 de 4

Hemodinamia: evoluciona con disfuncion multiorganica asociada a fiebre. actualmente en shock septico con requerimiento de 2 DVA. Nora 0.33 y adrenalina 0.03 PAM 65. lactico 22, acidotico, frio a distal, volemizo con 1000cc o.9% corrige llenado capilar <3seg, tibio a distal, pendiente HC03.

Ventilatorio: vmi tot 15/10 AL 20-10. trastorno deglutorio severo. reintubado 24/10/24 actualmente 3er dia. TAC torax con imagen de neumonia aspirativa bibasal. CAET sin bacterias. pafi 230 fiO2 40%->0.35. disminuyo SAS 1--> 2. Gatilla esporadicamente 1FR sobre el Prefijado, no es conflicto.

Infeccioso: Ingresa en contexto de compromiso de conciencia, diagnostico de meningitis por S. pneumoniae MS, recibiendo ceftriaxona 2gr c/12h IV desde ingreso con plan de 14 dias de esquema, parametros inflamatorios en descenso Blandos 18.000 ->14.000, PCR 58->39. CAET, orina y hemocultivos de ingreso negativos. Hoy con fiebre >38°, sin quiebre clinico. indico paracetamol, se sospecha broncoaspiracion, paciente extubado con trastorno deglutorio severo. de persistir con fiebre y quiebre clinico, cobertura para gram positivos y negativos intrahospitalario. evoluciona con nuevo Shock septico con disfuncion multiorganica, recultivado, aun con meningitis purulenta, pendiente Cultivo de LCR. se escala terapia a meropenem vancomicina en dosis meningeas, en espera de cultivos. CAET negativos. componente neumonico asociado, PCR 122 (previo 110) sin fiebre, mantengo esquema.

Metabolico renal: cursando nuevamente con AKI 2 progresiva Crea 2.0 bun 68, diuresis presente 1300cc/24h. se corrige vec, en espera de descenso de nitrogenados. aun recibiendo dosis plena de atb, hasta respuesta inflamatoria, ajustar a funcion renal con cultivos.

Neurologico: Paciente ingresa 15/10 con diagnostico de meningitis por S. pneumoniae MS. evaluado Scanner de ingreso por neurologia quien sugiere TAC control dado sospecha de hidrocefalia y edema cerebral. scanner 17/10 evaluado por neurocirugia descartan hidrocefalia, mejoría de edema. Paciente evoluciona con Glasgow 11/14 CON tot. Extubado 20/10. Neurologia sugiere esquema de dexametasona por 5 dias actualmente cumplido, y ceftriaxona por 14dias. descartan riesgo de convulsion, suspendo anticonvulsivante. evoluciona con fiebre y shock, LCR control con meningitis pultacea, sin hidrocefalia. se escala Terapia meropenem vancomicina, en espera de cultivos.

Nutricion: NE bien tolerada.

Nota 20:20 paciente presenta paro cardiorrespiratorio tipo asistolia asociado a hipotension severa, se realiza 1 ciclo de reanimacion saliendo a taquicardia ventricular con pulso, se administra 300mg de amiodarona, queda con nora 0.45 Adrena 0.15. se evidencia cambios electrocardiograficos, solicito Troponinas, electrolitos, GSA, lactico.

resultado de examenes: acidotico con Ph 7.21 HC03 15 k 6.1 CALCIO 7.8 TROPONINA 1600

Solicito EKG control.

28/10/2024 10:14:26

M.Lasso

INFECTOLOGIA

Paciente ingreso el 15/10 con meningitis bacteriana por S pneumoniae MS.

Tratamiento antibiotico con ceftriaxona y luego se rota a vancomicina y meropenem a dosis de SNC.

Destaca:

Foco alternativo de neumonia evidente en TAC.

LCR con mejoría de CQ y cultivo (-)

LCR: 15/10 y 24/10 Cel=370 (88% PMN) y 12360 (65% PMN), Prot 17,1 y 2,4 gr, Gluc <5 y 71 cultivo S pneumoniae MS y ahora negativo.

Ascenso de celularidad, con normalización de glucosa, descenso de proteinas y cultivos negativos.

Fecha Epicrisis : 28/10/2024 20:18

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 28-10-2024 20:18:37

Página 3 de 4

SNC no ha sido invadido por lo que es muy poco probable que tenga un agente nosocomial involucrado.
TAC sin evidencia de alteraciones.
Neurología solicita RNM para descartar complicaciones.
HC 22/10 negativos.
CAET 24/10 negativo
Corresponde suspensión de vancomicina.
Mantener meropenem 2g c/8h por 3 días mas pensando en foco respiratorio y pulmonar.
Posterior a ello pasar a ceftriaxona 2g c/12h ev hasta disponer de RNM solicitada.
Tomar nuevo CAET.

28/10/2024 19:19:55

C.Garcia

Paciente extremadamente grave. Se recibe con 2 DVA en dosis de 037 ug/K/min de NAD y 0,08 ug/k/m. de adrenalina, en FA con amiodarona y 120 de FC. Se solicita ECo cardio para evaluar función cardíaca. Se visualiza insuficiencia aórtica importante, con aumento de tamaño auricular que podría explicar una FA crónica. La insuficiencia aórtica evoluciona con diastólicas extremadamente bajas.
Función hepática muy alterada con alza enzimática significativa que podría reflejar hígado de shock e isquemia hepática.
Función renal muy deteriorada por lo que se indica hemodiálisis continua.
Hemodinamia: Se decide disminuir adrenalina y eventualmente cambiar por dobutamina para disminuir postcarga.
Noradrenalina se mantiene y se aumenta aporte de volumen en base a albúmina durante hemodíalisis.
Diuresis escasa, no depura.BUN 83, crea 2,63. ELP normales.

Infeccioso: visto por infectología: mantener ertapenem por 3 días después cambiar a ceftriaxona. Buscar foco neumónico. LCR impresiona mejor. Se toma nuevo CAET

Sin deposiciones hace 7 días.

Acidosis metabólica, se agrega bicarbonato.

Herpes bucal

SAS 1-2

Edema de extremidades.

Se coloca catéter de diálisis bajo eco femoral derecho

Pendiente RNM de cerebro

HD continua

Manejo hemodinámico teniendo en cuenta insuficiencia aórtica

19: 40 hace PCR. en asistolía.

Se realizan maniobras 2 ciclos, no sale del paro. previamente el complejo comenzó a enancharse , se toman GSA y tiene Ph 7,2.

Fallecimiento 19:50

Diagnóstico de Egreso

Meningitis - shock séptico

Condición de Egreso Fallecido

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Fecha Epicrisis : 28/10/2024 20:18

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 28-10-2024 20:18:37

Página 4 de 4

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Carolina Garcia Klapp

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 28/10/2024 20:18

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:37

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar